

Secuencia de diagnóstico de TTM (estilo Okeson)

Cómo pensar el caso · Qué hacer y qué NO hacer

Paso 1 · Historia clínica dirigida

- Dolor: localización, tipo, intensidad, factores que lo aumentan o disminuyen, horario (mañana → bruxismo/nocturno).
- Ruidos articulares: clic, crepitación; si el clic desapareció y bajó la apertura → sospecha progresión a sin reducción.
- Limitación de apertura, bloqueos, traumatismos, hábitos (apretar, morder objetos), estrés, sueño.
- Tratamientos previos (férulas, ajustes, ortodoncia, rehabilitación).

Paso 2 · Exploración

- Apertura máxima (dolorosa y no dolorosa), desviación, protusión, laterales.
- Palpación muscular ($\approx 1-2$ kg): masetero, temporal, pterigoideos (vía intraoral si procede), cervicales.
- Palpación articular lateral y posterior; ruidos con estetoscopio o palpación.
- Análisis oclusal: RC, MIC, deslizamiento, interferencias de trabajo/balance/protrusiva, facetas.

Paso 3 · Clasificar el trastorno (Okeson)

Decide primero si el problema principal es **muscular**, **articular** o mixto:

- **Muscular**: co-contracción protectora, dolor muscular local, dolor miofascial (puntos gatillo + referido), mioespasmo, mialgia crónica.
- **Articular – disco**: desplazamiento con reducción (clic recíproco), sin reducción (bloqueo cerrado), con bloqueo intermitente.
- **Articular – superficies / inflamación**: incompatibilidades, adherencias, sinovitis, capsulitis, retrodiscitis, artritis.

Paso 4 · Tratar según la estructura afectada

Okeson prioriza terapia **reversible** primero: educación, control de parafunción, fisioterapia, férula de estabilización. La terapia oclusal irreversible (tallado, ortodoncia, rehabilitación) solo cuando el cuadro está estable y hay una indicación clara.

Qué NO hacer (errores frecuentes)

NO ajustar la oclusión de forma agresiva en un paciente con dolor agudo muscular o articular. Primero controla inflamación e hiperactividad; después reevalúa la oclusión.

NO colocar una férula de reposicionamiento anterior "porque hay clic". Muchos clics asintomáticos no requieren tratamiento. El reposicionamiento es de uso limitado y con controles estrictos.

NO asumir que toda interferencia debe eliminarse. Si el paciente está adaptado y sin daño, la interferencia puede no ser el problema prioritario.

NO confundir Clase de Angle con Clase de Morris, ni usar Morris como si fuera el sistema diagnóstico de Okeson.

SÍ: historia + exploración → clasificar (músculo vs articulación) → terapia reversible → reevaluar → solo entonces terapia irreversible si está indicada.

Checklist rápido de férula de estabilización bien hecha

Criterio	Verificación
Retención	Se sostiene sola; entra y sale sin forzar
Estabilidad	No bascula al presionar de un lado
Contactos en cierre	Puntiformes, uniformes y simultáneos en todos los antagonistas (en RC)
Protrusiva	Guía anterior que desocluye posteriores

Lateralidad	Guía canina (o de grupo controlada) que desocluye el resto
Superficie	Lisa, pulida, sin filos; grosor ≈2–3 mm en posteriores
Controles	Reajustar con papel de articular: la férula cambia con el uso

Referencias Okeson 5.^a ed.: Caps. 8–11 (signos, historia, diagnóstico, consideraciones generales de tratamiento); Cap. 15 (férulas).
 Dr. Miguel Alvarado Avilés · Catedrático · Dentipedia